

26-1

목 통증

Neck pain

질환 이해 › 채점 역산 › 실전 실행 › 인출

감별 대축

신경학적 침범이 있는가. 목에서 끝나는가, 팔로 내려가는가

관문

발열 · 목 경직 › 수막염 / 체중감소 · 암 병력 › 척추 종양 / 교통사고 › 골절 · 채찍질

놓치면 안 됨

수막염. 목이 뻣뻣하다는 말은 근골격과 감염 양쪽을 다 가리켜요

가장 흔한 정답

근막통증증후군 · 경추염좌 · 경추간판탈출증

시간 예산

Hx 5분 / PEx 4분 / Edu 2~3분. 진찰과 교육이 둘 다 무거워요

이 CC의 함정

DTR을 SP가 연기해 주지 않아요. 해머로 제대로 쳐서 실제로 유발시켜야 해요

목 통증과 허리 통증은 원래 한 항목으로 묶여 있지만, 문진 뼈대만 닳았을 뿐 질환 목록 · red flag · 신체진찰이 전부 달라요. 그래서 이 시리즈에서는 26-1 목과 26-2 허리로 나눠 만들었어요. 두 문서를 같이 펴 놓고 비교하면 어디가 닳고 어디가 다른지가 분명해집니다.

PART 0

이 CC에서 만나는 질환 지도

목 통증의 감별은 세 덩어리예요. 신경학적 이상, 신경 외 근골격, 그리고 기타(감염·종양·류마티스).

이 세 덩어리가 그대로 결정 트리의 뼈대가 돼요. 그런데 주의할 게 하나 있어요. **세 번째 덩어리인 기타가 사실상 red flag 상자**예요. 수막염·척추 종양·전방 구조물 종양이 여기 들어 있고, 이들은 감별 순서상 나중에 아니라 **먼저 지워야** 하는 것들이거든요. 그래서 이 가이드는 기타를 대축 뒤가 아니라 대축 앞의 관문으로 올렸어요.



관문으로 기타를 먼저 지우고, 그 다음 신경 침범 여부로 좌우가 갈린다

0-1. 질환들의 첫인상

덩어리	질환	환자가 보이는 모습
신경학적	경추간판탈출증	목에서 팔을 지나 손가락까지 저리고 아파요. 목을 뒤로 젖히면 확 심해지고요
신경학적	척추관협착증	50세 이상에서 서서히 나빠지고, 목과 어깨에서 양쪽 팔 신경을 따라 통증이 내려와요
신경학적	척추 종양	체중이 빠지고 예전에 암 진단을 받은 적이 있어요. 배뇨장애 같은 여러 이상이 같이 와요
근골격	경추염좌	뒷목 아래 양쪽이 둔하게 쏘셔요. 움직이면 심해지고 쉬면 나아요. 팔로 뻗치진 않고요

덩어리	질환	환자가 보이는 모습
근골격	근막통증증후군	목이 빠근하면서 뒤통수가 당겨요. 아픈 자리를 손가락으로 정확히 짚고, 만지면 단단한 때가 잡혀요
근골격	채찍질 손상	교통사고 뒤부터 목이 아프고 두통·어지럼·구역까지 같이 와요
기타·감염	수막염	열이 나고 감기 기운이 있으면서 목이 뻣뻣해요. 목 통증으로 위장한 응급이에요
기타·류마티스	류마티스 관절염	아침에 뻣뻣하고, 목 말고 다른 관절도 아파요
기타·연관통	삼차신경통	얼굴이 갑자기 칼로 찌르듯 아파요. 목이 아니라 얼굴이 주 무대예요
기타·종양	전방 구조물 종양	목소리가 변하고 발음이 힘들고 침 삼키기가 어려워요. 체중도 빠지고요

스스로 답해보기

Q 목 통증의 세 덩어리를 대고, 그중 대축 앞의 관문으로 올려야 하는 건 어느 것인가?

Q "팔로 뻗친다"는 말이 나왔을 때 즉시 올라가는 후보와 즉시 내려가는 후보는?

PART 1

가장 큰 축은 신경 침범이에요

목에서 끝나는가, 팔로 내려가는가. 이 질문 하나가 목 통증 질환을 반으로 가릅니다.

1-1. 왜 신경 침범이 대축일까요?

이유가 셋이에요. 첫째, **질문 두세 개로 판정돼요**. 팔로 뻗치는가, 힘이 빠지는가, 감각이 둔한가. 둘째, **진찰로 확인**이 돼요. 상지 감각 · 근력 · DTR과 Spurling · Lhermitte. 셋째, **치료 방향이 통째로 갈려요**. 신경 침범이 없으면 보존적 치료로 끝나고, 있으면 영상과 수술 논의로 넘어가요.

반대로 통증 양상을 대축으로 삼으면 안 되는 이유도 분명해요. 경추염좌 · 채찍질 손상 · 근막통증증후군이 전부 **빠른** 함으로 갈거든요. 양상만으로는 셋이 안 갈려요. 양상은 대축이 아니라 근골격 칸 안에서 셋을 가르는 보조 도구예요.

문서 전체에서 계속 돌아올 질문 – 이 통증이 목에서 끝나는가, 아니면 팔로 내려가는가.

1-2. 대축 앞의 관문 – 기타 다섯을 먼저 지워요

여기서 관문을 먼저 통과시켜야 하는 이유는 배점이 아니라 **안전**이에요. 발열과 목 경직을 동반한 목 통증은 수막염일 수 있고, 체중감소와 암 병력을 동반한 목 통증은 전이성 척추 종양일 수 있어요. 두 경우 모두 경추간판탈출증으로 진단을 붙이는 순간 케이스가 통째로 틀려요.

발열 · 오한 · 감기 증상 · 목 뻣뻣함 수막염. 누워서 수막 자극 징후로 확인해요. **관문**

체중 감소 · 암 진단 병력 척추 종양. 폐암 · 유방암 · 전립선암이 대표적이에요. **관문**

교통사고 · 외상 골절 · 탈구 · 채찍질 손상. 사건이 특정되면 영상이 먼저예요. **관문**

목소리 변화 · 발음 곤란 · 연하곤란 전방 구조물 종양. 목 뒤가 아니라 목 앞의 문제예요. **관문**

얼굴이 전기 통하듯 찌르다 삼차신경통. 목 진찰을 아무리 해도 답이 안 나와요. **관문**

목이 뻣뻣하다는 말을 근골격으로만 읽으면 안 돼요

학생이 흔히 하는 판단이 이거예요. 목이 뻣뻣하다니까 경추염좌나 근막통증증후군이라고요. 그런데 **수막염 환자도 정확히 같은 말을 해요**. 뻣뻣함 자체는 두 방향 모두를 가리켜요.

고치는 법은 간단해요. 뻣뻣하다는 말이 나오면 **반드시 발열 · 두통 · 감기 증상을 붙여 물어요**. 그리고 진찰에서 수막 자극 징후를 확인해요. 진찰 마지막에 누워서 수막 자극 징후를 보게 되어 있는 건 장식이 아니에요.

1-3. 실제로 헛갈리는 두 쌍

방사통 vs 연관통

방사통은 신경뿌리가 눌러 그 신경이 지배하는 경로를 따라 통증이 선처럼 내려가는 거예요. 목 > 팔 > 손가락. 저림이 함께 오고요. **연관통**은 다른 곳의 병이 목에서 느껴지는 거예요. 수막염과 뇌신경통이 여기 속하고, 경로를 따라가지 않고 저림도 없어요.

구분하는 질문은 이거예요. **어디서 어디까지 뻗치는지 손으로 그려 주시겠어요?** 선으로 그려지면 방사통이에요.

Spurling vs Lhermitte

Spurling은 목을 뒤로 젖히고 아픈 쪽으로 기울인 뒤 위에서 눌러요. 추간공이 좁아져 신경뿌리가 눌리고 팔로 방사통이 재현되죠. 즉 **신경뿌리** 검사예요. **Lhermitte**는 목을 앞으로 굽혀요. 전기 통하는 느낌이 등을 따라 엉덩이까지 내려가고요. 즉 **척수** 검사예요.

방향이 반대(젖힘 vs 굽힘)이고 잡는 구조물이 달라요(뿌리 vs 척수). **두 검사 이름만 외우고 방향을 바꿔 시행하면 아무 소견도 안 나와요.**

스스로 답해보기

Q 대축을 판정하는 문진 질문 세 개와 진찰 두 개는?

Q Spurling과 Lhermitte는 목을 각각 어느 방향으로 움직이고 무엇을 잡는가?

PART 2

최소 기초 세 덩어리

딱 세 개만 깔고, 셋 다 뒤에서 회수해요.

2-1. 경추에는 신경이 두 층으로 지나가요

목뼈 가운데의 척추관에는 **척수**가 지나가고, 뼈마디 옆의 추간공으로는 **신경뿌리**가 팔을 향해 빠져나가요. 같은 목 안에 위아래로 흐르는 통로 하나와 옆으로 빠지는 통로 여러 개가 함께 있는 구조예요.

병소가 어느 층이나에 따라 증상이 완전히 달라져요. 신경뿌리가 눌리면 그 뿌리가 담당하는 팔의 특정 구역만 저리고 힘이 빠져요. **한쪽, 국소적**이죠. 척수가 눌리면 그 아래 전부가 영향을 받아요. **양쪽, 다리까지, 보행 장애와 배뇨 이상**.

추간판이 옆으로 튀어나오면 뿌리를 누르고, 가운데로 튀어나오거나 척추관이 전반적으로 좁아지면 척수를 눌러요. 쉽게 말하면 **같은 추간판 탈출이라도 튀어나온 방향이 그림을 바꾸는** 셈이에요.

› 이 개념은 3-1 경추간판탈출증의 편측 방사통, 1-3의 Spurling과 Lhermitte 구분, PART 7의 상지 감각·근력 검사에서 회수돼요.

2-2. 피부분절과 근절 - 어느 뿌리인지는 손이 알려줘요

각 신경뿌리는 팔의 정해진 구역을 담당해요. 그래서 환자가 엄지가 저리다고 하면 C6, 새끼손가락이 저리다고 하면 C8 근처의 문제라는 게 즉시 나와요. **문진 답 한 줄이 병소의 높이를 지목하는 거예요.**

뿌리	감각·저린 곳	근력	반사
C5	삼각근 부위	팔꿈치 굽히기	이두근 반사
C6	엄지	손목 젖히기	이두근·상완요골
C7	중지	팔꿈치 펴기	삼두근 반사
C8	새끼손가락	손가락 굽히기	-
T1	아래팔 안쪽	손가락 벌리기	-

환자가 저리다고 말한 손가락 하나가 병소의 높이를 지목한다.

상지 피부분절·근절·반사. 저린 손가락 하나가 높이를 알려준다

DTR도 같은 논리예요. 이두근 반사는 주로 C5~C6, 삼두근 반사는 주로 C7 계열을 봐요. 반사가 떨어져 있으면 그 높이의 뿌리가 눌린 거고, 반대로 **향진되어 있으면 그보다 위쪽 척수의 문제**를 의심해요.

› 이 개념은 3-1 경추간판탈출증, PART 6의 A 추간판탈출증 질문, PART 7의 상지 감각·근력·DTR 평가에서 회수돼요.

2-3. 근막 유발점 - 왜 목이 아픈데 뒤통수가 당길까요?

근육을 싸고 있는 근막에는 국소적으로 과민해진 지점이 생길 수 있어요. 만지면 단단한 띠처럼 잡히고, 그 지점을 누르면 원래 아프던 곳이 아닌 **다른 곳으로 통증이 퍼져요**. 이게 유발점(trigger point)이에요.

목 뒤 근육의 유발점은 뒤통수 쪽으로 통증을 보내요. 그래서 환자가 목이 빠근한데 뒤통수가 당긴다고 말하죠. 신경뿌리 방사통과 달리 **저림이 없고, 경로가 신경 지배 구역과 맞지 않아요**.

유발점이 활성화되면 국소 자율신경 반응이 함께 나오기도 해요. 땀이 나고 털이 곤두서요. 그리고 치료가 유발점을 직접 겨냥해요. 활동성 유발점에 바늘을 삽입해 파괴하는 것, 그러니까 IMS와 TPI가 그거예요.

› 이 개념은 3-3 근막통증증후군, PART 6의 A 자율신경 증상 질문, PART 7의 압통점 촉진, PART 8의 IMS · TPI에서 회수돼요.

스스로 답해보기

- Q 신경뿌리 병변과 척수 병변의 증상이 어떻게 다른가?
 - Q 엄지가 저리다는 말이 지목하는 신경뿌리는?
 - Q 근막 유발점 통증이 방사통과 다른 점 두 가지는?
-

PART 3

핵심 질환 한 바퀴

열 개 중 다섯만 정상에서 고장까지 돌리고, 나머지는 결정 단서 한 줄로 압축해요. 고르는 기준은 빈도가 아니라 **덩어리의 대표**인지예요.

3-1. 경추간판탈출증

왜 목을 젖히면 심해지고, 왜 손가락까지 저릴까요?

환자

목이 아픈데 어깨를 지나 팔로 내려가요.

엄지 쪽이 저릿저릿합니다.

목을 뒤로 젖히면 확 심해져요. 컴퓨터 오래 보고 나면 더하고요.

결정적인 건 **선처럼 내려가는 통증 + 저림 + 목 젖힘에서 악화** 세 가지예요. 목에서 끝나지 않고 팔로 내려간다는 것만으로 대축이 신경 침범 쪽으로 넘어가고, 저린 손가락이 병소의 높이를 알려주고, 젖힘에서 악화된다는 게 추간공 이야기 해요.

왜 추간판이 튀어나올까요?

추간판은 가운데가 젤리 같은 수핵이고 바깥이 질긴 섬유테로 감싸인 구조예요. 나이가 들거나 반복 하중을 받으면 섬유테에 미세한 균열이 생기고, 그 틈으로 수핵이 밀려 나가요. 목은 무거운 머리를 이고 하루 종일 앞으로 숙이는 자세를 반복하니까 하중이 계속 걸려요.

왜 목을 젖히면 심해질까요?

신경뿌리가 빠져나가는 추간공은 **목을 젖히면 좁아지고 숙이면 넓어져요**. 이미 튀어나온 추간판이 자리를 차지하고 있는데 통로까지 좁아지면 신경이 더 눌리죠. 쉽게 말하면 좁은 문에 짐이 하나 놓여 있는데 문을 더 닫는 셈이에요.

Spurling test가 정확히 이걸 인위적으로 만드는 검사예요. 젖히고, 아픈 쪽으로 기울이고, 위에서 눌러서 추간공을 최대한 좁혀요.

왜 저림이 같이 올까요?

신경뿌리에는 운동 섬유와 감각 섬유가 함께 지나가요. 눌리면 감각 섬유가 먼저 예민해져 저림과 찌릿함이 생기고, 더 진행되면 운동 섬유가 영향을 받아 힘이 빠져요. **그래서 저림은 초기 신호, 근력 저하는 진행 신호**예요.

왜 대부분 수술을 먼저 하지 않을까요?

튀어나온 수핵은 시간이 지나면 수분이 빠지고 몸이 흡수해서 줄어들 수 있어요. 그래서 물리 치료 · 보조기 · 진통제로 시간을 벌면서 기다리는 게 원칙이에요. 다만 예외가 있어요. **다리 힘이 급격히 약해지거나 대소변 기능에 장애가 생기면 응급으로 넘어가요**.

쌍둥이 감별 - 경추염좌. 둘 다 목이 아프고 자세와 관련 있어요. 갈라주는 건 **팔로 뻗치나요, 저리나요** 한 문장이에요. 염좌는 방사통이 없어요.

CPX 연결. L에서 목에서 팔로 내려가는 경로를 그리게 하고 > A 추간판탈출증에서 팔 힘과 감각을 묻고 > F 자세에서 젖힐 때 악화를 확인하고 > PEx에서 상지 감각 · 근력 · DTR과 Spurling > 검사는 C-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 보존적 치료 우선과 응급 상황을 설명해요.

SP 언어 사인 목에서 팔로 내려가요 · 엄지가 저려요 · 목을 젖히면 확 심해져요 · 팔에 힘이 없어요

3-2. 경추염좌

왜 뒷목 아래 양쪽이고, 왜 쉬면 나아질까요?

환자

어제 잠을 잘못 잤는지 뒷목이 빠근해요.

양쪽 아래쪽이 둔하게 쑤시는데, 움직이면 더 아프고 가만히 있으면 좀 나아요.

팔로 내려가거나 저리진 않아요.

여기서 결정적인 건 **팔로 내려가거나 저리진 않다**예요. 이 한 문장이 대축을 근골격 쪽으로 넘겨요. 그리고 **움직이면 악화, 쉬면 완화**가 기계적 원인이라는 표시고요.

왜 근육과 인대가 다칠까요?

목의 근육과 인대는 무거운 머리를 붙잡고 미세하게 계속 일하고 있어요. 잠자리에서 목이 오래 꺾여 있거나 갑자기 큰 힘이 걸리면 근섬유와 인대에 미세 손상이 생겨요. 손상 부위에 염증 매개물질이 나와 통증과 근경직을 만들고요.

왜 움직이면 아프고 쉬면 나아질까요?

손상된 조직에 장력이 걸려야 아프기 때문이에요. 목을 움직이면 다친 근육과 인대가 늘어나면서 통증 수용체를 자극 하죠. 가만히 두면 장력이 사라지니 통증도 줄고요. **염증성 질환이 움직이면 나아지는 것과 정확히 반대라**, 이 방향 하나로 류마티스 계열을 걸러낼 수 있어요.

왜 방사통이 없을까요?

병소가 근육과 인대이지 신경뿌리가 아니거든요. 눌린 신경이 없으니 그 신경이 지배하는 경로를 따라 퍼질 이유가 없어요. 쉽게 말하면 **전선이 아니라 전선을 감싼 벽이 다친** 셈이에요.

쌍둥이 감별 - 채찍질 손상. 둘 다 빠근하고 방사통 없이 올 수 있어요. 갈라주는 건 **교통사고가 있었나**요와 **두통 · 어지럼 · 구역이 같이 오나**예요.

CPX 연결. O에서 잠자리나 자세 사건을 잡고 › L에서 뒷목 하부 양측임과 방사통 없음을 확인하고 › F에서 움직이면 악화 · 쉬면 완화를 받아내고 › PEx에서 압통점 촉진과 목 ROM › Edu에서 낮은 베개, 자세 교정, 찜질과 스트레칭을 설명해요.

SP 언어 사인 잠을 잘못 잤어요 · 뒷목이 빠근해요 · 움직이면 더 아파요 · 팔로 내려가진 않아요

3-3. 근막통증증후군

왜 목이 아픈데 뒤통수가 당길까요?

환자

목이 늘 빠근한데 뒤통수가 당기는 느낌이에요.

여기가 아파요, 하고 손가락으로 딱 짚을 수 있어요.

아플 때 땀이 나고 팔에 소름이 돋기도 해요.

결정적인 건 셋이에요. **아픈 부위가 명확하다, 뒤통수로 퍼진다, 자율신경 증상이 같이 온다.** 목 통증에서 가장 흔한 원인이면서, 이 세 가지가 모이면 다른 질환과 잘 안 겹쳐요.

왜 유발점이 생길까요?

같은 자세를 오래 유지하면 특정 근섬유 다발만 계속 수축한 상태로 있게 돼요. 그 부위는 혈류가 줄고 대사산물이 쌓이면서 과민해지고, 결국 딱딱한 띠로 만져지는 **단단한 매듭**이 돼요.

왜 다른 곳으로 퍼질까요?

유발점에서 올라온 신호가 척수의 같은 분절로 들어가면서, 뇌가 통증의 출처를 근처 다른 부위로 잘못 읽기 때문이에요. 그래서 목 뒤 유발점의 통증이 뒤통수에서 느껴져요. **신경 지배 경로를 따르지 않는다는 점**에서 방사통과 같어요.

왜 땀이 나고 털이 곤두설까요?

활성 유발점은 국소 자율신경 반응을 함께 일으켜요. 발한과 입모가 대표적이고요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않는 증상이라, 물어서 나오면 진단이 크게 기울어요.

왜 바늘을 찌를까요?

유발점은 약으로 풀기 어려운 **기계적인 매듭**이에요. 그래서 바늘로 직접 자극해 수축한 근섬유 다발을 풀어 줘요. IMS와 TPI가 그거고, 마사지 · 온열 치료 · 소염진통제가 함께 갑니다.

쌍둥이 감별 - 경추간판탈출증. 둘 다 목에서 시작해 다른 데로 퍼져요. 갈라주는 건 **저림이 있냐**와 **어디까지 퍼지나**예요. 근막통증은 저림이 없고 뒤통수 쪽으로, 추간판탈출은 저림과 함께 팔 · 손가락으로 가요.

CPX 연결. L에서 아픈 자리를 손으로 짚게 하고 > C에서 빠근한 양상을 확인하고 > A 근막통증에서 땀과 털이 곤두서는지를 묻고 > 사에서 근무 자세와 스트레스를 확인하고 > PEx에서 압통점과 단단한 띠를 촉진 > Edu에서 자세 교정과 스트레칭, 필요하면 IMS를 설명해요.

SP 언어 사인 뒤통수가 당겨요 · 여기가 딱 아파요 · 만지면 뭉친 게 잡혀요 · 아플 때 땀이 나요

3-4. 채찍질 손상

왜 목만 아픈 게 아니라 머리와 속까지 불편할까요?

환자

이틀 전에 뒤에서 차에 받혔어요.
그때는 괜찮았는데 다음 날부터 목이 아프고 두통이 있어요.
어깨도 아프고 속이 메스껍고 가끔 어지럽습니다.

결정적인 건 **교통사고라는 사건 + 지연 발현 + 목 밖의 증상들**이에요. 목만 아픈 게 아니라 두통 · 어깨 통증 · 구역 · 구토 · 어지럼이 같이 온다는 게 이 진단의 그림이에요.

왜 채찍질이라고 부를까요?

뒤에서 충격을 받으면 몸통이 먼저 앞으로 밀리고 머리가 뒤에 남았다가, 곧이어 머리가 앞으로 튕겨 나가요. 목이 **과신전 후 과굴곡**으로 채찍처럼 휘두르는 거죠. 이 짧은 순간에 근육 · 인대 · 관절낭이 동시에 늘어나요.

왜 다음 날부터 아플까요?

사고 직후엔 교감신경이 항진되어 통증을 덜 느끼고, 손상 부위의 염증 반응은 몇 시간에서 하루에 걸쳐 자리를 잡기 때문이에요. 그래서 **사고 당시 괜찮았다는 말이 이 진단을 배제하지 않아요**. 오히려 전형적인 경과예요.

왜 두통과 어지럼이 같이 올까요?

목 위쪽 관절과 근육에서 올라오는 신호가 뇌간에서 삼차신경 경로와 만나기 때문에 목의 문제가 두통으로 느껴질 수 있어요. 그리고 목의 고유수용 감각은 균형에도 관여해서 손상되면 어지럼과 구역이 따라올 수 있고요.

쌍둥이 감별 - 골절 · 탈구. 같은 사건에서 생기고 겉으로는 안 같려요. 그래서 **외상 병력이 있으면 영상이 먼저**예요. 신경학적 이상이 있으면 더 급해지고요.

CPX 연결. O에서 교통사고 사건과 지연 발현을 잡고 > A에서 두통 · 구역 · 어지럼을 확인하고 > 외에서 사고 상황과 다른 부위 골절을 묻고 > PEx에서 압통 · ROM · 상지 신경학적 검사 > 검사는 C-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 경추 보조기, 침상 안정, 진통제를 설명해요.

SP 언어 사인 뒤에서 받혔어요 · 그때는 괜찮았어요 · 다음 날부터 아파요 · 머리가 아프고 어지러워요

3-5. 수막염

왜 목 통증으로 위장한 응급일까요?

환자

어제부터 열이 나고 감기 기운이 있어요.
머리가 깨질 것 같고 목이 뻣뻣해서 숙여지지 않아요.
불빛이 눈부시고 토할 것 같습니다.

결정적인 건 **발열 + 두통 + 목 경직**의 조합이에요. 목이 뻣뻣하다는 말은 근골격 질환에서도 나오지만, **열과 두통이 붙으면 이야기가 완전히 달라져요.**

왜 목이 뻣뻣해질까요?

수막에 염증이 생기면 수막이 예민해져서, 목을 숙여 수막이 당겨지는 동작에 반사적으로 근육이 수축해 저항해요. 환자 입장에서는 목이 굳어 안 숙여지는 걸로 느껴지고요. 쉽게 말하면 **아픈 곳을 안 늘리려고 몸이 스스로 잠그는** 셈이에요.

왜 감기 증상이 앞에 올까요?

많은 경우 상기도에서 시작한 감염이 혈행을 타고 중추신경계로 들어가기 때문이에요. 그래서 며칠 전 감기 기운이라는 진술이 앞에 붙어요.

왜 빨리 진단해야 할까요?

세균성 수막염은 시간 단위로 나빠지고 후유증이 남을 수 있어요. 그래서 이 케이스를 만나면 목 진찰에 시간을 쓸 게 아니라 **수막 자극 징후 확인과 뇌척수액 검사로 방향을 즉시 틀어야** 해요.

쌍둥이 감별 - 경추염좌. 둘 다 목이 뻣뻣해요. 갈라주는 건 **열이 나나요, 두통이 있나요, 최근 감기를 앓았나요** 세 질문이에요. 진찰에서 수막 자극 징후로 확인하고요.

CPX 연결. A 전신에서 발열을 받아내고 > A 수막염에서 두통 · 감기 증상 · 목 뻣뻣함을 묻고 > PEx 마지막에 누워서 수막 자극 징후 > 검사는 Spinal tapping과 CSF, 뇌 영상 > Edu에서 즉시 치료가 필요한 이유를 설명해요.

SP 언어 사인 열이 나요 · 머리가 깨질 것 같아요 · 목이 안 숙여져요 · 불빛이 눈부셔요

3-6. 나머지 다섯은 결정 단서만

질환	덩어리	결정 단서	검사 · 치료
척추관협착증	신경학적	50세 이상, 서서히 악화, 목과 어깨에서 양팔 신경근을 따라	C-spine X-ray · CT/MRI / 침상 안정 · NSAID · 경추 보조기
류마티스 관절염	기타 · 류마티스	아침에 뻣뻣, 다른 부위에도 통증	C-spine X-ray · RF · anti-CCP · ESR · CRP / NSAID · 스테로이드 · MTX
척추 종양	기타 · 종양	체중 감소, 이전 암 진단(폐 · 유방 · 전립선), 배뇨장애 등 여러 이상	C-spine X-ray · MRI / 수술 · 항암화학요법 · 방사선 치료
삼차신경통	기타 · 연관통	얼굴이 주로 찌르는 듯 갑작스럽게 아프다	Brain MRI / carbamazepine · 수술
전방 구조물 종양	기타 · 종양	체중 감소, 목소리 변화, 발음 힘들, 연하 곤란	Neck CT / 수술

3-7. 네 질환의 얼굴을 한 장으로

가장 자주 부딪히는 넷을 네 축으로 비교하면 그림이 굳어요. **C 양상 · 방사 · A 동반 · F 악화**인이 그 넷이에요.

	C 양상	방사	A 동반	F 악화
추간판탈출증	찌르듯 · 한쪽	있음	근력 · 감각 저하	목 젖힘
경추염좌	빠근 · 뒷목 아래 양측	없음	—	움직이면 악화 · 쉬면 완화
채찍질 손상	빠근	있음	교통사고 · 두통 · 구역 · 어지럼	—
근막통증증후군	빠근 · 뒤통수 당김	불명확	아픈 부위 명확 · 땀 · 털섬	—

스스로 답해보기

- Q 경추간판탈출증에서 목을 젖히면 왜 심해지는가?
- Q 근막통증의 퍼짐이 방사통과 다른 점 두 가지는?
- Q 채찍질 손상에서 사고 당시 괜찮았다는 말이 왜 배제 근거가 못 되는가?

PART 4

채점 역산표

이 CC는 진찰과 교육이 둘 다 무거워서, 문진을 5분 안에 효율적으로 끝내는 게 중요해요.

4-1. MUST

L 방사통 대축을 가르는 질문. 목에서 끝나는가 팔로 내려가는가. **MUST**

A 전신 · 수막염 발열 · 두통 · 목 경직. 응급을 걸러내요. **MUST**

A 추간판탈출증 팔 힘이 약해졌는지, 감각이 둔한지. **MUST**

A 체중 변화 암 전이를 지목해요. **MUST**

C 양상 · 강도 찌르듯 · 전기 · 빠르함 중 무엇인가. **MUST**

F 자세 젖힐 때 악화인지, 움직이면 악화인지. **MUST**

외 외상 · 교통사고 골절과 채찍질 손상을 세워요. **MUST**

과 · 약 · 골다공증 검사 여부 골절과 종양의 배경. **MUST**

4-2. SHOULD와 DROP

등급	항목	왜 그 등급인가
SHOULD	A 삼차신경통 · 전방 구조물 · 근막통증	해당 방향으로 케이스가 기울 때 결정적이에요
SHOULD	D 지속시간 · 빈도, Ex 이전 삽화와 치료 반응	경과와 치료 반응이 진단 정보가 돼요
SHOULD	사 직업 · 근무 자세 · 스트레스	근막통증과 염좌의 배경이자 교육에서 교정할 대상이에요
SHOULD	가 류마티스 · 척추 · 신경계 가족력	자가면역과 유전성 질환의 사전 확률
DROP	E 건강검진	감별을 못 줍혀요. 가장 먼저 자릅니다
DROP	Co 점점 심해지나요	O · D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠지면 종양을 올려요
DROP	여 폐경	목 통증 감별에 거의 기여하지 않아요

버리는 순서는 E > 여 > Co > D 빈도예요. MUST 여덟 개는 어떤 경우에도 지켜요.

PART 5

문진 개관

목 통증 문진은 두 가지를 동시에 해요. 통증 자체를 해부하는 일과, red flag를 훑는 일.

앞쪽 절반(O·L·D·Co·Ex·C)은 통증의 성격을 잡아요. 어디서 시작해 어디로 가는지, 어떤 양상인지, 얼마나 되었는지. **여기서 방사통 하나가 대축을 결정해요.**

뒤쪽의 A는 성격이 달라요. 일곱 줄이 각각 질환을 겨냥하고 있고, 그중 **전신과 수막염 두 줄은 응급을 걸러내는 관문**이예요. 그래서 A는 순서대로 다 읽는 게 아니라, 앞쪽에서 좁혀 놓은 방향에 맞춰 골라 던져요.

F는 다리 역할을 해요. **자세**는 대축을 보조하고(젖히면 악화 = 추간공), **운동**은 염증성과 기계적을 갈라요(쉬면 악화 = 류마티스).

문진의 뼈대 한 줄 – 방사통으로 대축을 정하고, red flag 두 줄을 던지고, 남은 방향에만 A의 해당 줄을 붙인다.

5-1. 암기법

항목	암기법	풀이
A 동반	목이 아파 탈출 시도하는 삼수생 종근	탈출 – 추간판탈출증(팔 힘·감각)·삼 – 삼차신경통(얼굴 전격통)·수 – 수막염(두통·감기·목 경직)·종 – 전방 구조물 종양(목소리·연하곤란)·근 – 근막통증증후군(땀·털섬)
C 양상	TRaSH CLaN	압통·발적·종창·열감·비빔소리·운동제한·NRS

PART 6

History taking

대본 순서 그대로 갑니다.

6-1. O – 언제부터, 그리고 어떤 사건에서

목 통증의 O에는 다른 CC에 없는 갈래가 있어요. **사건을 특정하는 질문**이에요. 자동차 사고와 목 빼끗이 대표적이고, 사건이 잡히면 외상성 질환군이 통째로 올라와요.

O 발생 MUST

언제부터 목이 아팠나요? 갑자기인가요, 서서히인가요? 특별히 어떤 상황에서 시작되었나요?

시작 시점과 사건을 동시에 받아요. 자동차 사고나 목 빼끗이 나오면 외상성 질환군이 한꺼번에 올라와요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 가리는 이유
자동차 사고 뒤	채찍질 손상 · 골절	과신전 후 과굴곡으로 근육 · 인대 · 관절낭이 동시에 늘어난다
사고 일어나서 · 목 빼끗	경추염좌	목이 오래 꺾여 있으면 근육과 인대에 미세 손상이 생긴다
서서히 몇 달	협착증 · 근막통증 · 종양	구조 변화가 누적되어야 증상이 나오므로 경과가 길다
며칠 전 감기 뒤	수막염	상기도 감염이 혈행을 타고 중추신경계로 들어간다
컴퓨터 · 스마트폰 사용 뒤	근막통증 · 추간판	고정 자세가 특정 근섬유와 추간판에 하중을 누적시킨다

6-2. L – 대추를 가르는 항목

L이 이 CC의 대추를 담당해요. 손으로 짚게 하고, 어디까지 뻗치는지 그리게 해요. **선으로 그려지면 방사통**이고 그 순간 신경학적 이상 칸으로 넘어가요.

I 부위 · 방사 MUST

통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요? 통증이 어디로 뻗어나요? 목 외에 아픈 곳은 없나요?

대축을 가르는 항목이에요. 방사 경로를 손으로 그리게 하면 방사통과 연관통이 구분돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
목에서 팔 · 손가락까지 선처럼	경추간판탈출증	신경뿌리가 눌리면 그 신경이 지배하는 경로를 따라 퍼진다
뒷목 하부 양측에 국한	경추염좌	병소가 근육과 인대라 신경 경로를 따라갈 이유가 없다
뒤통수로 당긴다	근막통증증후군	유발점 신호를 뇌가 근처 다른 부위로 잘못 읽는다
양쪽 팔 모두	척추관협착증 · 척수병증	가운데 통로가 좁아지면 양측이 함께 영향을 받는다
얼굴이 아프다	삼차신경통	목이 아니라 얼굴이 주 무대인 질환이다
목 외에 다른 관절도	류마티스 관절염	전신 자가면역이면 목만 아플 이유가 없다

6-3. D · Co · Ex

D 지속 · 빈도 SHOULD

통증이 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?

지속과 빈도가 발작성인지 지속성인지를 갈라요. 삼차신경통은 짧고 반복적이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
몇 초에서 몇 분, 반복	삼차신경통	신경 자극이 발작적으로 방전되는 형태다
하루 종일 지속	근막통증 · 만성 염좌	지속적인 근긴장과 유발점이 계속 자극을 만든다
자세를 바꾸면 잠깐	추간판탈출증	추간공 넓이가 자세에 따라 변한다
점점 길어진다	종양 · 진행성 병변	구조 변화가 누적되면 증상 없는 시간이 줄어든다

Co 진행 DROP

통증이 점점 더 심해지나요?

O · D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠진다는 답은 종양과 척수병증을 위로 올려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
계속 나빠진다	종양 · 척수병증	병변이 커지거나 압박이 진행되고 있다
좋아졌다 나빠졌다	근막통증 · 염좌	자세와 사용량에 따라 오르내린다
비슷하게 유지	만성 협착증	구조적 협착은 단기간에 잘 변하지 않는다

Ex 과거 삽화 · 치료 반응 SHOULD

이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요? 진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?

치료 반응이 진단 정보가 돼요. 소염제에 반응하면 염증성, 파스에만 반응하면 표재성 근육통 쪽이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 가리는 이유
전에도 같은 통증이 있었다	만성 · 재발성	구조적 원인이나 자세 습관이 계속 남아 있다
진통제를 먹으면 좋아진다	염증성 · 근골격	약물 반응성 자체가 간접 근거가 된다
약을 먹어도 그대로	신경병증 · 종양	일반 진통제로 조절되지 않으면 기전이 다르다
처음이다	급성 사건	반복 패턴이 없으면 새로 생긴 원인을 찾는다

6-4. C – 양상이 세 질환을 가릅니다

목 통증의 양상은 셋으로 갈려요. 칼로 찌르듯이면 신경, 전기가 통하듯이면 척수나 신경, 둔하고 빠근하면 근골격이에요. 이 셋을 문장으로 제시해서 고르게 하면 환자가 훨씬 정확하게 답해요.

C 양상 · 강도 MUST

통증이 어떤 양상인가요? 칼로 찌르듯인가요, 전기가 통하듯인가요, 둔하고 빠근한가요? 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 하면 몇 점인가요?

양상 하나로 신경성과 근골격성이 갈려요. 선택지를 주면 환자가 정확하게 답해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 가리는 이유
칼로 찌르듯 · 한쪽	경추간판탈출증	신경뿌리 압박은 날카롭고 편측성으로 나타난다
전기가 통하듯	신경 · 척수	신경 섬유의 이상 방전이 전기 같은 감각으로 느껴진다
둔하고 빠근	염좌 · 근막통증 · 채찍질	근육과 인대의 손상은 둔통으로 나타난다
얼굴이 전격적으로	삼차신경통	짧고 강한 발작성 통증이 특징이다
8점 이상	급성 · 신경 압박 · 감염	통각 역치가 크게 낮아진 상태다

6-5. A – 일곱 줄로 red flag까지

A의 첫 두 줄이 응급을 담당해요. 전신(체중 변화 = 암 전이)과 수막염(두통 · 감기 · 목 경직)이에요. 나머지 다섯 줄은 케이스 방향에 맞춰 골라 던져요.

A 전신 MUST

발열이나 오한이 있나요? 피로하거나 체중이 변하지는 않았나요?

발열은 감염, 체중 감소는 암 전이를 지목해요. 두 red flag를 한 줄로 훑어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
열이 난다	수막염 · 척추 감염	감염이 전신 순환으로 새어 나가 체온 조절점을 올린다
체중이 빠진다	척추 종양 · 전방 구조물 종양	악성 질환의 소모 증상이다
전신 증상 없음	근골격 · 신경학적	국소 원인이면 전신 반응이 생길 이유가 없다

A 추간판탈출증 MUST

팔이나 손 힘이 약해졌나요? 팔이나 어깨 감각이 둔한 느낌이 있나요?

신경 침범의 진행 신호예요. 저림은 초기, 근력 저하는 진행. 수술 논의의 기준이 되기도 해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
팔 힘이 약해졌다	신경뿌리 · 척수 압박	감각 섬유 다음으로 운동 섬유가 영향을 받는다
특정 손가락만 둔하다	해당 신경뿌리 병변	피부분절이 병소의 높이를 지목한다
양쪽 다리까지 힘이 없다	척수병증	척수가 눌리면 그 아래 전부가 영향을 받는다
없다	신경 침범 근거 약함	다만 방사통만 있어도 신경학적 이상 칸에 남긴다

A 수막염 MUST

두통이 있나요? 감기 증상이 있었나요? 목이 뻣뻣해서 안 숙여지나요?

목 통증으로 위장한 응급을 걸러내요. 뻣뻣하다는 말이 나오면 반드시 이 줄을 붙여요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
셋 다 있다	수막염	수막 염증이 목 굽힘에 반사적 근수축을 만든다
두통만 심하다	뇌신경통 · 다른 두통	목 외 원인을 함께 고려한다
빛이 눈부시다 · 토할 것 같다	수막염	수막 자극과 두개내압 증가의 흔한 동반 증상이다
없다	감염 가능성 낮음	근골격 방향으로 계속 진행한다

A 삼차신경통 SHOULD

얼굴에 전기가 통하는 듯한 통증이 있나요?

얼굴이 주 무대인 질환을 걸러내요. 목 진찰로는 답이 안 나오는 케이스예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
얼굴이 갑자기 찌른다	삼차신경통	삼차신경의 발작성 이상 방전이다
세수하거나 씹을 때 유발	삼차신경통	가벼운 자극이 방아쇠가 되는 것이 특징이다
없다	해당 없음	목 자체의 원인으로 계속 진행한다

A 전방 구조물 SHOULD

목소리가 변하거나 발음이 어렵지는 않나요? 침 삼킬 때 아프거나 걸리나요?

목 뒤가 아니라 목 앞의 문제를 걸러내요. 체중 감소와 함께 오면 종양을 강하게 시사해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
목소리가 변했다	전방 구조물 종양	되돌이후두신경 침범이나 종괴 압박이 발성에 영향을 준다
삼킬 때 걸린다	연하곤란·종양	식도나 인두를 누르는 구조가 있다
구역·구토가 같이	종양·두개내압	동반 증상이 있으면 영상 검사를 서두른다
없다	전방 구조물 배제	목 뒤 구조물로 초점을 좁힌다

A 근막통증증후군 SHOULD

통증이 있을 때 땀이 나거나 털이 곤두서는 느낌이 있나요?

활성 유발점의 국소 자율신경 반응이에요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않아요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
땀이 나고 소름이 돋는다	근막통증증후군	활성 유발점이 국소 자율신경 반응을 함께 일으킨다
아픈 자리를 정확히 짚는다	근막통증증후군	유발점은 국소적이라 환자가 위치를 명확히 안다
없다	다른 근골격 원인	염좌나 채찍질 쪽으로 무게가 옮겨간다

A 경추 염좌 SHOULD

목을 구부리기 어려운가요?

굽힘 제한은 근육과 인대의 손상을 시사해요. 다만 수막염에서도 안 숙여지므로 발열을 함께 봐요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
굽히기 어렵다 · 열은 없다	경추염좌	손상된 근육과 인대에 장력이 걸려 아프다
굽히기 어렵다 · 열이 있다	수막염	수막 자극에 의한 반사적 근수축이다
돌리기가 더 어렵다	염좌 · 근막통증	회전에 관여하는 근육의 손상을 시사한다

6-6. F · E · 외 · 과 · 약 · 사 · 가 · 여

F 자세 · 운동 MUST

통증을 악화시키거나 완화시키는 요인이 있나요? 특별히 통증이 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? 휴식 시에 완화되나요, 아니면 움직이면 완화되나요?

자세는 대축을 보조하고, 휴식과 운동의 방향은 염증성과 기계적을 갈라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
목을 뒤로 젖히면 악화	경추간판탈출증	젖히면 추간공이 좁아져 신경뿌리가 더 눌린다
움직이면 악화 · 쉬면 완화	경추염좌	손상 조직에 장력이 걸려야 아프다
쉬면 오히려 악화 · 아침에 심함	류마티스 질환	밤새 고인 삼출액이 아침에 흩어지는 데 시간이 걸린다
고개 숙이면 전기가 내려간다	척수병증 · Lhermitte	목 굽힘이 척수를 당긴다
자세와 무관	감염 · 종양	기계적 자극과 무관하면 조직 자체의 병변이다

E 건강검진 DROP

이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?

이 CC에서 감별을 좁히지 못해요. 가장 먼저 자릅니다.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
골밀도가 낮다고 들었다	골다공증 · 골절 위험	드물지만 나오면 압박골절의 배경이 된다
특별한 건 없었다	정보 없음	예상되는 가장 흔한 답이라 DROP이다

외 수술 · 외상 MUST

목 수술을 받으신 적 있으세요? 목을 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?

외상 사건은 골절과 채찍질을 세우고, 다른 부위 골절력은 골다공증을 시사해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
교통사고 이력	채찍질 손상 · 골절	사건과 증상이 붙으면 구조물 손상이 먼저다
목 수술 이력	수술 후 변화 · 인접부 문제	수술 부위 위아래에 부하가 옮겨 간다
가볍게 넘어졌는데 골절된 적	골다공증	낮은 에너지 손상에서 골절되면 골강도가 낮다는 뜻이다
없다	외상성 질환 배제	사건이 없으면 구조물 손상 가설이 약해진다

과 과거력 MUST

이전에 진단 받은 병이 있나요? 고혈압, 당뇨, 결핵, 류마티스 질환, 골다공증, 암은 어떠신가요?

암 병력은 척추 전이를, 결핵은 척추 감염을, 골다공증은 골절을, 류마티스는 경추 침범을 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
암 진단을 받은 적 있다	척추 종양 · 전이	폐 · 유방 · 전립선암이 척추로 잘 전이된다
결핵을 앓은 적 있다	척추 결핵	감염이 척추체를 침범하면 만성 통증으로 온다
골다공증	압박골절	골강도가 낮으면 가벼운 힘에도 무너진다
류마티스 질환	경추 침범	자가면역 활막염이 경추 관절도 침범할 수 있다
없다	기저 질환 배경 없음	일차 근골격 · 신경 원인으로 접근한다

약 약물 SHOULD

현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 통증이 호전되나요?

치료 반응이 진단 정보가 되고, 스테로이드 장기 복용은 골강도를 떨어뜨려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
소염진통제에 반응	염증성 · 근골격	약물 반응성이 간접 근거가 된다
진통제로 조절 안 됨	신경병증 · 종양	기전이 달라 일반 진통제가 듣지 않는다
스테로이드 장기 복용	골다공증 · 압박골절	골형성이 억제되어 골강도가 떨어진다
복용 약 없음	특이 배경 없음	약물 관련 요인을 배제한다

사 생활 · 근무 자세 SHOULD

술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요? 스트레스를 많이 받으시나요? 최근에 격한 운동을 하셨나요?

근무 자세와 스트레스가 근막통증과 염좌의 배경이자 교육에서 교정할 대상이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
컴퓨터 앞에 오래 앉아 있다	근막통증 · 추간판	고개를 앞으로 뺀 자세가 하중을 크게 늘린다
고개를 자주 젖히는 일	추간판탈출증	젖힘이 반복되면 추간공이 반복해서 좁아진다
스트레스가 많다	근막통증증후군	지속적 근긴장이 유발점을 만든다
최근 격한 운동	염좌 · 근육통	갑작스러운 부하가 미세 손상을 만든다

가 가족력 SHOULD

가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요? 류마티스 질환이나 척추, 신경계 질환이 있는 분은요?

자가면역과 일부 척추 질환은 가족 집적성이 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
류마티스 질환 가족력	류마티스 관절염	자가면역 감수성 배경을 공유한다
척추 질환 가족력	구조적 · 유전적 소인	추간판과 척추 형태에 유전적 요소가 있다
없다	사전 확률 낮음	배제는 못 하지만 순위가 내려간다

여 폐경 DROP

폐경은 언제 하셨나요?

항목표에 있으니 시간이 되면 물어요. 골다공증 배경으로만 의미가 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
폐경 후	골다공증 위험	에스트로겐 감소가 골소실을 가속한다
해당 없음	정보 없음	감별에 추가 정보를 주지 않는다

스스로 답해보기

Q L 항목 하나가 왜 이 CC의 대축을 담당하는가?

Q A 일곱 줄 중 응급을 담당하는 두 줄은?

Q 목이 안 숙여진다는 말에서 염좌와 수막염을 가르는 질문은?

PART 7

Physical examination

목 통증 진찰의 핵심은 셋이에요. 압통점을 찾고, 목 ROM을 재고, 상지의 신경학적 이상을 잡는 것.

그리고 이 CC에는 다른 데 없는 함정이 하나 있어요. **DTR을 SP가 연기해 주지 않아요.** 해머로 제대로 쳐서 실제로 반사를 유발시켜야만 관찰할 수 있어요. 평소에 친구들끼리 꼭 연습해 뒀야 하는 이유예요.

7-1. 동선



이 동선의 함정

DTR은 SP가 연기해 주지 않는다. 해머로 제대로 쳐서 실제로 유발시켜야 보인다

무릎 꿇고서 치기 가가. 그럼. 바나나를 하에 하며 쳐서 반사를 유도하지 않는다

앉아서 대부분을 끝내고, 수막 자극 징후만 누워서

- 시작**
손 씻기 › 진찰 동의 › 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다.
- 앉아서**
뒤로 돌아주세요. 통증 부위를 보고 만져요. **압통점이 있는지가** 근막통증과 염좌를 가르는 소견이에요.
- 앉아서**
목 ROM 평가. 굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전 네 방향.
- 앉아서**
상지 감각 · 근력 · DTR. 피부분절과 근절을 뿌리별로, DTR은 이두근과 삼두근.
- 앉아서**
Spurling test › Lhermitte sign. 방향이 반대이므로 순서대로.
- 누워서**
수막 자극 징후. 발열이나 두통이 있으면 절대 생략하지 않아요.
- 마무리**
협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

왜 이 순서일까요? **환자를 한 번만 눕히기 위해서예요.** 앉은 자세에서 시진 · 촉진 · ROM · 신경학적 검사 · 특이검사를 전부 끝내고, 마지막에 한 번 눕혀 수막 자극 징후만 봐요. 그리고 환자가 불편해하지 않도록 목은 조심스럽게 다뤄야 해요.

7-2. 진찰마다 무엇을 잡나

진찰	무엇을 보는가	지목하는 질환
시진	자세 · 변형 · 피부 병변	외상 · 감염 · 자세 이상
촉진 · 압통점	단단한 띠, 정확히 짚히는 압통	근막통증증후군
목 ROM	굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전	굽힘 제한은 염좌 · 수막염, 젖힘 시 통증은 추간판
상지 감각	C5~T1 피부분절	저린 손가락이 병소의 높이를 지목
상지 근력	C5~T1 근절	근력 저하는 신경 침범의 진행 신호
DTR	이두근 · 삼두근	저하는 뿌리, 항진은 그보다 위 척수
Spurling	신경뿌리 압박	경추간판탈출증 · 신경근병
Lhermitte	척수 자극	경추척수병 · 척수 병변
수막 자극 징후	수막 염증	수막염

7-3. 특이검사 카드

이름만 외우면 시험장에서 손이 안 나가요. **이 절만 읽고 친구와 마주 앉아 연습을 시작할 수 있어야 해요.**

스퍼링 검사 Spurling's test

환자 자세

앉아서. 검사자는 환자 뒤에 서요.

내 손 동작

1. 환자에게 목을 뒤로 젖히게 해요(신전).
2. 아픈 쪽으로 목을 기울이게 해요(측방굴곡).
3. 양손을 겹쳐 환자 머리 위에 얹고 아래로 지그시 눌러요.

양성 판정

누르는 동안 목에서 팔로 내려가는 방사통이 재현되면 양성이에요. 목만 아픈 건 양성이 아니에요.

무엇을 잡나

신전과 측방굴곡이 추간공을 좁혀요. 거기에 측방향 압박을 더해 눌린 신경뿌리를 더 압박하는 겁니다.

흔한 실수

목만 아프다는 걸 양성으로 읽는 것. 그리고 힘이 부족하면 유발이 안 돼요. 반대로 척수병증이 의심되면 무리하게 누르지 않아요.

레르미트 징후 Lhermitte sign

환자 자세

앉아서. Spurling과 방향이 반대예요.

내 손 동작

1. 환자에게 목을 앞으로 천천히 굽히게 해요(굴곡).
2. 턱이 가슴에 닿도록 최대한 숙이게 해요.
3. 무엇이 느껴지는지 물어요.

양성 판정

전기가 통하는 느낌이 등을 따라 아래로, 엉덩이나 팔다리까지 내려가면 양성이에요.

무엇을 잡나

목을 굽히면 척수가 위아래로 당겨져요. 탈수초되었거나 눌린 척수는 이 견인에 이상 방전으로 반응합니다.

흔한 실수

Spurling과 방향을 헷갈려 젖히는 것. 그러면 척수가 안 당겨져 아무 소견도 안 나와요.

수막 자극 징후 Meningeal irritation signs

환자 자세

누워서. 진찰의 마지막에.

내 손 동작

1. 한 손을 뒤통수에 대고 목을 천천히 굽혀요(경부 강직).
2. 고관절과 무릎을 90도로 굽힌 뒤 무릎을 펴 봐요(Kernig).
3. 목을 굽혔을 때 환자의 무릎과 고관절이 저절로 굽는지 봐요(Brudzinski).

양성 판정

목이 저항하며 안 굽혀지거나, 무릎을 펴 때 저항과 통증이 있거나, 목을 굽혔더니 다리가 따라 굽으면 양성이에요.

무엇을 잡나

염증이 생긴 수막은 당겨지면 아파요. 그래서 수막을 늘리는 동작마다 몸이 반사적으로 저항합니다.

흔한 실수

발열이나 두통이 있는데 이 진찰을 건너뛰는 것. 목 통증에서 놓치면 가장 큰 대가를 치르는 항목이에요.

상지 신경학적 검사 Upper limb neuro exam

환자 자세

앉아서. 반드시 양측 비교.

내 손 동작

1. 감각 - C5 삼각근 부위, C6 엄지, C7 중지, C8 새끼손가락, T1 아래팔 안쪽을 좌우 비교해요.
2. 근력 - C5 팔꿈치 굽히기, C6 손목 젖히기, C7 팔꿈치 펴기, C8 손가락 굽히기, T1 손가락 벌리기.
3. DTR - 이두근과 삼두근 반사를 해머로 제대로 쳐요.

양성 판정

특정 뿌리 구역만 감각이 둔하거나 근력이 약하면 그 높이의 신경뿌리 병변, 반사가 항진되어 있으면 척수 병변을 시사해요.

무엇을 잡나

각 신경뿌리가 담당하는 피부 구역과 근육이 정해져 있어요. 그래서 어느 구역이 나쁜지가 병소의 높이를 알려줍니다.

흔한 실수

DTR을 살살 쳐서 유발이 안 되는 것. SP는 연기해 주지 않으므로 실제로 나와야 관찰돼요. 그리고 양측 비교를 빼면 기준이 없어요.

7-4. 감점 포인트

- 발열이나 두통이 있는데 수막 자극 징후를 확인하지 않음
 - Spurling과 Lhermitte의 방향을 바꿔 시행함
 - DTR을 약하게 쳐서 반사가 유발되지 않음
 - 상지 감각 · 근력 · 반사를 양측 비교하지 않음
 - 압통점을 찾지 않고 넘어감. 근막통증의 핵심 소견이에요
 - 목 ROM을 네 방향 전부 보지 않음
 - 환자를 여러 번 눕혔다 앉혔다 하며 시간을 태움
 - 손 씻기 · 진찰 동의 · V/S 언급 누락
 - 목을 거칠게 다루어 환자가 불편해함
-

스스로 답해보기

- Q Spurling에서 목만 아픈 것을 왜 양성으로 읽으면 안 되는가?
 - Q DTR이 이 CC에서 특별히 강조되는 이유는?
-

PART 8

검사 계획

기본은 두 줄이에요. 영상과 근전도.

검사	왜 · 언제	근거
Cervical X-ray	거의 모든 케이스의 기본. 정렬 · 골절 · 퇴행 변화를 봐요	[관행]
Cervical CT / MRI	신경학적 이상이 있거나 보존적 치료에 반응하지 않을 때	[GL]
근전도 EMG	신경뿌리 병변의 높이와 정도를 확인할 때	[GL]
Spinal tapping · CSF	수막염이 의심될 때. 뇌 CT/MRI를 함께 고려해요	[상황부]
Brain MRI	삼차신경통이 의심될 때	[상황부]
Neck CT	전방 구조물 종양이 의심될 때	[상황부]
RF · anti-CCP · ESR · CRP	아침에 뻣뻣하고 다른 관절도 아플 때	[상황부]
임상 증상으로 판단	근막통증증후군은 영상이 아니라 압통점과 증상으로 진단해요	[관행]
발열 · 목 경직인데 영상만 계획	수막염을 놓치는 가장 흔한 경로예요	[금기]

8-1. 치료 계획

단계	내용
1	찜질 및 물리 치료
2	약물 치료 – NSAIDs
3	경추염좌 – Neck brace
4	근막통증증후군 – IMS(근육내 자극), TPI(유발점 주사)
5	추간판탈출증 – 보존적 치료로 조절되지 않으면 수술적 치료

PART 9

Education

보존적 치료를 먼저, 그리고 응급 상황을 반드시 알려줘요.

9-1. 교육 대사의 뼈대

단계 말할 문장

공감 목 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.

추정 진단 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 경추간판탈출증이 가장 의심됩니다.

감별 진단 하지만 목 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 경추염좌, 근막통증증후군도 완전히 배제할 수 없습니다.

검사 따라서 정확한 진단을 위해 경추 X-ray와 CT, MRI 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?

치료 만약 검사로 경추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것입니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.

예후 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

9-2. 생활교육

교육 왜 이렇게 말하나

베개를 낮은 것으로 높은 베개는 목을 밤새 굽힌 상태로 두어 근육과 인대에 장력을 걸어요

근무 자세 교정 고개를 앞으로 뺀 자세가 목에 걸리는 하중을 크게 늘려요. 근무 환경의 자세가 질환을 악화시켜요

무리한 운동은 피하고 급격한 부하는 손상을 키워요. 다만 완전한 안정이 답은 아니에요

찜질 · 마사지 · 스트레칭 주기적인 가벼운 스트레칭과 마사지가 근긴장을 풀어 통증을 완화시켜요

보존적 치료가 먼저 신경학적 증상이 악화되는 환자가 아니면 물리 치료 · 진통제 · 보조기로 시작하고, 통증이 호전되지 않을 때 수술을 논의해요

수술은 응급이 아니에요 다리 힘이 급격히 약해지거나 대소변 장애가 생기는 경우가 아니면 응급하게 시행하지 않아도 돼요

9-3. 이런 증상이면 즉시 오세요

갑자기 배변이나 배뇨에 장애가 생길 때 **최우선**

팔 힘이 갑자기 빠지거나 움직일 수 없을 정도의 통증이 생길 때

다리 힘이 약해지거나 걷기가 힘들어질 때

열이 나면서 목이 뻣뻣하고 머리가 심하게 아플 때

9-4. PPI 대사 뱅크

상황

준비 문장

오프닝	목이 아프시면 일하실 때도 많이 불편하셨을 것 같습니다. 천천히 말씀해 주세요.
방사 경로 확인	통증이 어디서 시작해서 어디까지 가는지 손으로 한번 그려 주시겠어요?
양상 유도	칼로 찌르는 느낌인가요, 전기가 통하는 느낌인가요, 아니면 둔하고 빠근한가요?
진찰 전 안내	이제 목을 살펴보겠습니다. 아프시면 바로 말씀해 주세요. 조심해서 하겠습니다.
Spurling 전	목을 뒤로 젖히고 살짝 눌러볼 텐데, 팔로 내려가는 느낌이 있으면 말씀해 주세요.
DTR 전	망치로 가볍게 두드릴 텐데 놀라지 마세요. 힘을 빼고 계시면 됩니다.
수술 걱정	대부분은 수술 없이 물리 치료와 약으로 좋아집니다. 수술은 신경 증상이 나빠질 때만 고려합니다.
클로징	제가 말씀드린 것 중에 더 궁금하신 점 있으실까요?

PART 10

케이스 통합 연습

신경 침범이 있는 것과 없는 것, 그리고 응급인 것으로 대비되는 둘.

10-1. 케이스 A – 신경학적 이상

환자

마흔두 살 남자입니다. 두 달 전부터 목이 아파요.
오른쪽 어깨를 지나 팔로 내려가고 엄지 쪽이 저립니다.
목을 뒤로 젖히면 확 심해져요. 요즘 컴퓨터를 오래 봅니다.
열은 없고 체중도 그대로예요.

① 관문

발열 없음, 체중 변화 없음, 교통사고 없음, 목소리 정상, 얼굴 통증 없음. 기타 다섯이 전부 지워져요.

② 대축

팔로 내려가는 방사통 + 엄지 저림. **신경학적 이상 칸**. 목 젖힘에서 악화되니 추간공 이야기고, 엄지가 저리니 C6 근처예요.

③ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
A 추간판	팔 힘 · 감각	진행 신호가 있는지. 수술 논의의 기준
F 자세	젖힘에서 악화	추간공 협착을 지목
사	근무 자세	원인이자 교육 대상
외	외상 · 수술력	골절과 수술 후 변화 배제
Ex	진통제 반응	치료 반응이 진단 정보

④ 진찰과 계획

압통점 촉진 > 목 ROM 네 방향 > 상지 감각 · 근력 · DTR 양측 비교 > **Spurling** > Lhermitte. 검사는 C-spine X-ray와 CT/MRI, 필요하면 EMG. 교육은 보존적 치료 우선, 근무 자세 교정, 낮은 베개, 그리고 팔 힘이 갑자기 빠지거나 대소변 장애가 생기면 즉시 오라는 것.

점수를 만든 지점 – 방사 경로를 손으로 그리게 한 것, 팔 힘과 감각을 물어 신경 침범의 정도를 확인한 것, **Spurling**에서 방사통 재현을 확인한 것.

10-2. 케이스 B – 응급

환자

스물여섯 살 여자입니다. 어제부터 목이 뻣뻣해서 안 숙여져요.

머리가 깨질 것처럼 아프고 열이 납니다.
 사흘 전부터 감기 기운이 있었어요.
 불빛이 눈부시고 속이 메스껍습니다.

㉠ 관문에서 바로 걸려요

발열 + 두통 + 목 경직 + 선행 감기. **대축을 돌리기 전에 방향이 정해져요.** 경추염좌로 접근하면 케이스 전체가 틀립니다.

㉡ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
A 전신	발열 · 오한	감염을 맨 위로 올려요
A 수막염	두통 · 감기 증상 · 목 경직	세 가지가 모이면 확정에 가까워요
A	빛 눈부심 · 구역 · 구토	수막 자극과 두개내압 증가
과	면역저하 · 최근 감염	감염 위험 배경
L	방사통 여부	없으면 신경뿌리 병변에서 멀어져요

㉢ 진찰과 계획

목 통증 진찰에 시간을 쓰지 않아요. 목 ROM으로 굽힘 제한을 확인하고 **바로 누워서 수막 자극 징후**를 봐요. 검사는 Spinal tapping과 CSF, 뇌 CT/MRI. 교육은 즉시 치료가 필요한 이유예요.

점수를 만든 지점 – 목이 뻣뻣하다는 말에 발열과 두통을 붙여 물은 것, 수막 자극 징후를 진찰에 넣은 것, 검사 계획을 영상이 아니라 뇌척수액으로 튼 것.

두 케이스의 대비가 말해 주는 게 있어요. A는 **방사 경로**가, B는 **발열과 목 경직의 조합**이 진단을 만들었어요. 그리고 B는 대축을 돌리기도 전에 관문에서 끝났고요. **관문을 대축 앞에 두는 이유가 이겁니다.**

PART 11

3속도 복습

11-1. 시험 직전 1분 압축표

질환	영어리	결정 단서	진단	치료
경추간판탈출증	신경학적	목 > 팔 > 손가락 방사 + 저림, 젖히면 악화	C-spine X-ray, CT/MRI	침상 안정, 보조기, 진통제
척추관협착증	신경학적	50세 ⁺ , 서서히, 양팔 신경근 따라	C-spine X-ray, CT/MRI	침상 안정, NSAID, 경추 보조기
척추 종양	기타 · 종양	체중 감소, 암 병력, 배뇨장애	C-spine X-ray, MRI	수술, 항암, 방사선
경추염좌	근골격	뒷목 하부 양측 둔통, 움직이면 악화, 방사통 X	C-spine X-ray, CT/MRI	경추 보조기, 안정, 스트레칭
채찍질 손상	근골격	교통사고 후 목 통증 + 두통 · 구역 · 어지럼	C-spine X-ray, CT/MRI	경추 보조기, 안정, 진통제
근막통증증후군	근골격	뒤통수 당김, 아픈 부위 명확, 단단한 띠, 땀 · 털섬	임상 증상으로 판단	마사지, 온열, IMS · TPI
류마티스 관절염	기타	아침에 뻣뻣, 다른 부위도 통증	RF, anti-CCP, ESR, CRP	NSAID, 스테로이드, MTX
수막염	기타 · 감염	발열 + 감기 증상 + 목 경직	Spinal tapping, CSF, 뇌 영상	항생제, Dexamethasone
삼차신경통	기타 · 연관통	얼굴이 갑작스럽게 찌르듯	Brain MRI	carbamazepine, 수술
전방 구조물 종양	기타 · 종양	목소리 변화, 발음 힘들, 연하곤란, 체중 감소	Neck CT	수술

11-2. 미니케이스

상황	답
목에서 엄지까지 저리고 젖히면 심해져요 의심 · 진찰 1	경추간판탈출증 · Spurling test. 엄지 저림은 C6 근처
뒷목 양쪽이 빠근한데 팔로 안 내려가요 의심 · 가르는 질문	경추염좌 · 움직이면 악화되고 쉬면 완화되는지
뒤통수가 당기고 아픈 자리를 딱 짚어요 의심 · 추가 문진	근막통증증후군 · 땀과 털이 곤두서는 자율신경 증상

상황

답

열이 나고 목이 안 숙여져요
다음 행동

목 진찰에 시간 쓰지 말고 **수막 자극 징후 + Spinal tapping**

고개를 숙이니 등으로 전기가 내려가요
징후 이름과 의미

Lhermitte sign · 척수 자극. Spurling과 방향이 반대

교통사고 다음 날부터 목이 아프고 어지러워요
의심 · 왜 지연되나

채찍질 손상 · 손상 부위 염증 반응이 하루에 걸쳐 자리를 잡아요

목소리가 변하고 침 삼키기가 어려워요
의심 · 검사

전방 구조물 종양 · Neck CT. 체중 감소를 함께 확인

50대 후반, 서서히 나빠지고 양쪽 팔이 저려요
의심

척추관협착증 · 가운데 통로가 좁아지면 양측이 함께 영향받아요

11-3. Active recall

왜만 모았어요

- Q 왜 통증 양상이 아니라 신경 침범을 대축으로 삼는가?
- Q 왜 기타(감염 · 종양)를 대축 뒤가 아니라 앞에 두는가?
- Q 왜 목을 젖히면 추간판탈출증이 심해지는가?
- Q 왜 경추염좌에는 방사통이 없는가?
- Q 왜 근막통증의 통증이 뒤통수로 퍼지는가? 방사통과 무엇이 다른가?
- Q 왜 채찍질 손상은 사고 다음 날부터 아픈가?
- Q 왜 수막염에서 목이 뻣뻣해지는가?
- Q 왜 Spurling과 Lhermitte는 목을 반대 방향으로 움직이는가?
- Q 왜 DTR이 항진되면 뿌리가 아니라 척수를 의심하는가?
- Q 왜 대부분의 경추간판탈출증에서 수술을 먼저 하지 않는가?
- Q 왜 근막통증증후군은 영상이 아니라 임상 증상으로 진단하는가?
- Q 왜 저린 손가락 하나가 병소의 높이를 알려주는가?

PART 12

대본 전문

등급이 DROP인 항목도 전부 남겼어요. 시험 전날에는 이 표만 읽어요.

항목	말할 문장	등급
O	언제부터 목이 아팠나요? 갑자기 or 서서히?	MUST
O	특별히 어떤 상황에서 통증이 시작되었나요? (자동차 사고, 목 빼끗)	MUST
L	통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요?	MUST
L	목 외에 아픈 곳은 없나요?	SHOULD
L	통증이 어디로 뻗어나요?	MUST
D	통증이 얼마나 지속되나요?	SHOULD
D	하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?	SHOULD
Co	통증이 점점 더 심해지나요?	DROP
Ex	이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요?	SHOULD
Ex	진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?	SHOULD
C	통증이 어떤 양상인가요? (칼로 찌르듯이 / 전기가 통하듯이 / 둔하고 빠근)	MUST
C	압통(T)/발적(R)/종창(S)/열감(H)/움직일 때 소리(C)/움직임 제한(L)이 있나요?	SHOULD
C	안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 했을 때 몇 점인가요? (NRS)	MUST
A 전신	발열 / 오한 / 피로 / 체중 변화(암 전이)	MUST
A 추간판탈출증	팔이나 손 힘이 약해졌나요?	MUST
A 추간판탈출증	팔이나 어깨 감각이 둔한 느낌이 있나요?	MUST
A 삼차신경통	얼굴에 전기가 통하는 듯한 통증이 있나요?	SHOULD
A 수막염	두통 / 감기 증상 / 목 뻣뻣한 증상	MUST
A 전방 구조물	목소리 변화 / 발음 어려움 / 침 삼킬 때 통증 / 구역 / 구토	SHOULD
A 근막통증증후군	통증이 있을 때 땀이 나고 털이 곤두서는 증상이 있나요? (자율신경계 Sx)	SHOULD
A 경추 염좌	목을 구부리기 어려운가요?	SHOULD
F 자세	특별히 통증이 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? (굽힘 / 젖힘)	MUST
F 운동	휴식 시 통증이 완화되나요? 아니면 움직이면 완화되나요? (류마티스 질환)	MUST
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?	DROP

항목	말할 문장	등급
외 수술	목 수술 받으신 적 있으세요?	MUST
외 외상	목을 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?	MUST
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/결핵/류마티스 질환/골다공증/암)	MUST
약	현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 호전되나요?	SHOULD
사	술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요?	SHOULD
사	운동을 많이 하시는 편인가요? 최근에 격한 운동을 한 적이 있나요?	SHOULD
사	직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요?	SHOULD
사	스트레스를 많이 받으시나요?	SHOULD
가	가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요?	SHOULD
가	가족 중에 류마티스 질환 / 척추 / 신경계 질환이 있는 분이 있나요?	SHOULD
여	폐경	DROP

12-1. P/E 전문

구분 항목

도입	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정된 활력 징후는 정상입니다.
앉아서 1	뒤로 돌아주세요. 통증 부위 시진 / 촉진 (압통점 여부 확인)
앉아서 2	목 ROM 평가 (flexion, extension, lateral bending, rotation)
앉아서 3	상지 감각 / 근력 / DTR 평가 – 감각 C5 Deltoid, C6 엄지, C7 중지, C8 새끼손가락, T1 Medial forearm / 근력 C5 Elbow flex, C6 Wrist ext, C7 Elbow ext, C8 Finger flex, T1 Finger abduction / DTR Biceps, Triceps
앉아서 4	Spurling's test – 목 hyperextension, lateral flexion 후 위에서 누를 때 팔로 방사통
앉아서 5	Lhermitte sign – 목 flexion 시키면 전기 통하듯이 엉덩이까지 통증
누워서 6	수막 자극 징후
마무리	협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

12-2. keyword

목 통증의 경우 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염 · 종양 · 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 – 통증의 양상 / 강도, 수술 / 약물 / 골다공증 과거력 확인하기

악화 요인 – 휴식 · 아침에 악화(류마티스) ↔ 운동 시 악화(경추염좌), 자세 변화(경추간판탈출증)

신체 진찰 – (앉아서) 통증 부위 시진 · 촉진, 목 ROM, 상지 감각 · 근력 · DTR, Spurling, Lhermitte, (누워서) 수막 자극 징후

교육 – 보존적 치료(물리 치료 · 보조기 · 진통제) › 통증 호전 안 될 시 수술, 근무 환경 자세 교정, 스트레칭 · 마사지

응급 상황 교육 – 배변 · 배뇨 이상, 감각 · 근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

부록

원본과 어긋난 지점 · 출처

『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 26장(p.271~282) 단일 소스.

지점	원본	이 가이드
문서 분리	목 통증과 허리 통증이 26번 한 항목으로 묶여 있다	26-1 목과 26-2 허리로 분리했다. 원본도 감별 목록이 완전히 달라 주소를 듣고 나누어 생각하라고 하고 있으며, red flag와 신체진찰이 공유되지 않는다
신경학적 검사 범위	keyword 상자에는 목 통증에도 상지와 하지를 모두 적어 두었으나, P/E 항목표에는 상지만 있다	[확인 필요] P/E 항목표를 정본으로 삼아 상지를 필수로 두되, 척수병증이 의심되면 하지도 함께 보도록 동선 주석에 남겼다
기타 원인의 위치	감염 · 종양 · 류마티스를 세 번째 감별 덩어리로 나열	대축 뒤가 아니라 앞의 관문 으로 올렸다. 수막염과 척추 종양은 나중에 지우면 케이스가 통째로 틀리기 때문
특이검사 술기	검사 이름과 양성 소견만 제시	PART 7의 손동작 · 판정 · 기전 · 흔한 실수는 표준 술기를 풀어 쓴 것으로 원본에 명시된 내용이 아니다. 실습에서 확인할 것
시간 예산	병력 청취를 5분 내에 끝내기 빠듯하다는 서술만 있다	Hx 5분 / PEx 4분 / Edu 2~3분으로 제시했다 [관행]
Quick Sheet 대조	-	한글 단일 소스로 제작했다. Quick Sheet에만 있는 항목이 있다면 반영되지 않았다

출처: 『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 26. 목 통증(Neck pain) / 허리 통증(Low back pain), p.271~282.